

ΚΟΛΙΚΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ - ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ

Κλινική εικόνα: Συνήθως εμφανίζεται έντονο άλγος στο άνω δεξιό τεταρτημόριο και στο επιγάστριο, που συχνά συνοδεύεται από ναυτία και έμετο. Ο πόνος ενίοτε είναι αφόρητος, κορυφώνεται εντός 15-30 λεπτών και μπορεί να υποχωρήσει για αρκετές ώρες (κολικός). Πιθανώς να αντανakλά στον δεξιό ώμο και να επιδεινώνεται με την αναπνοή και το βήχα. Δεν υφίσταται με τη λήψη αντιόξινων (π.χ. *Maalox*, *Simeco*). Η κατάσταση μπορεί σταδιακά να επιδεινωθεί και να εξελιχθεί σε οξεία χολοκυστίτιδα, με επίμονο πόνο και πυρετό.

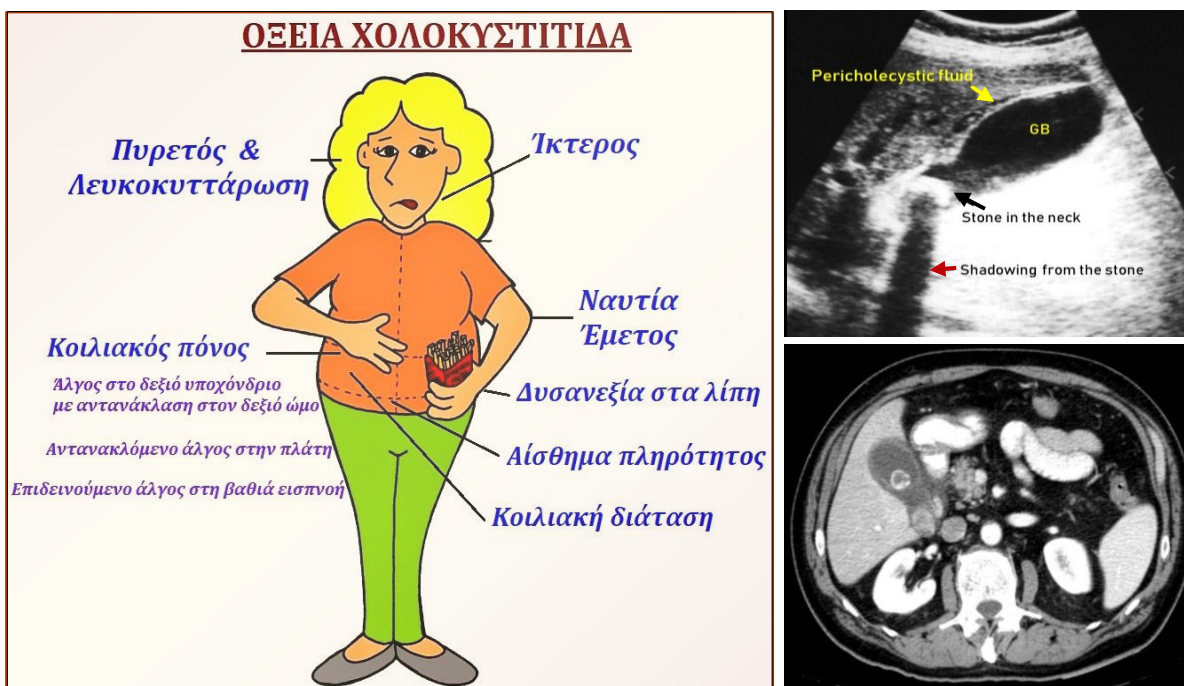
Ιστορικό: Αξιολόγηση του επεισοδίου του πόνου (π.χ. εμφάνιση - εντόπιση - διάρκεια - χαρακτήρας - αντανakλάσεις). Ελέγχουμε για άλλα συνοδά συμπτώματα (ναυτία, έμετος, πυρετός) κι αναλόγως σκεφτόμαστε την πιθανότητα οξείας χολοκυστίτιδας. Ο κολικός των χοληφόρων φαίνεται να ακολουθεί κινκασίριο ρυθμό, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης μεταξύ 9:00 π.μ και 4:00 μ.μ. Τυπικά – αλλά όχι πάντοτε – ο/η ασθενής με συμπτωματική χολολιθίαση είναι μια παχύσαρκη γυναίκα (με BMI > 30 kg/m²), αναπαραγωγικής ηλικίας (20-45 ετών), που εμφάνισε αιφνιδίως έντονο πόνο, περίπου 30-90 λεπτά μετά το γεύμα.

Προδιαθεσικοί παράγοντες, είναι: η ηλικία, το θηλυκό γένος, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παρατεταμένη νηστεία ή οι εξοντωτικές δίαιτες, η ταχεία απώλεια βάρους, η κίρρωση, οι αιμολυτικές διαταραχές, η ύπαρξη τέκνων, η λήψη αντισυλληπτικών, κ.λπ.

Διαφορική διάγνωση: Περιλαμβάνει τα κάτωθι: οξεία παγκρεατίτιδα, διάτρηση πεπτικού έλκους, οπισθοκυφλική σκοληκοειδίτιδα, οξεία χολαγγειίτιδα, κολικός ουροφόρων οδών, οξεία πυελονεφρίτιδα, μεσεντέριος ισχαιμία, επιδημική πλευροδυνία (νόσος του *Bornholm*), πνευμονική εμβολή, πλευρίτιδα, πνευμονία δεξιάς βάσεως, αλκοολική ηπατίτιδα, οξεία ιογενής ηπατίτιδα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, κ.ά.

Οξεία χολοκυστίτιδα, καλείται η φλεγμονή της χοληδόχου κύστεως, που προκαλείται από απόφραξη του κυστικού πόρου από λίθο, ο οποίος συνήθως ενσφηνώνεται στον θύλακο του Hartman. Σπανίως, μπορεί να διαπιστωθεί **οξεία αλβιθιασική χολοκυστίτιδα** (χωρίς λιθίαση), που αποτελεί βαριά κλινική οντότητα με υψηλή θνητότητα και συσχετίζεται με προηγούμενη χειρουργική επέμβαση, πρόσφατο μείζον τραύμα και σήψη, ή **εμφυσηματική χολοκυστίτιδα** σε ασθενείς άνδρες > 60 ετών, με ΣΔ, ανοσοκαταστολή, υποθρεψία, σήψη και αγγειοπάθεια.

Αντικειμενικά, διαπιστώνεται πυρετός, σημείο Murphy, έντονη ευαισθησία, σύσπαση και παλίνδρομος ευαισθησία στο δεξιό υποχόνδριο, ενώ στο 30% των περιπτώσεων ψηλαφάται η διατεταμένη χοληδόχος κύστη. Εργαστηριακά, εμφανίζεται λευκοκυττάρωση με αύξηση των ουδετεροφίλων, αύξηση CRP, αύξηση χολερυθρίνης και γ-GT και σπανίως των AST/ALT.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις, RR, SpO₂, και θερμοκρασία).
2. Τοποθετούμε ευρεία (# 16-18G) 3-way φλεβική γραμμή και ξεκινούμε την ενδοφλέβια χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυμάτων, ήτοι 500-1000 ml R/L ή R/S, για διόρθωση των πιθανών διαταραχών του ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών ή άλλων παραμέτρων.
3. Χορηγούμε ενδοφλεβίως 1 amp. Μετοκλοπραμίδη (*Primperan*) και 1 amp. Ondansetron (*Onda 4 mg*), μαζί με 1-2 amp. Σιμετιδίνη (*Tagamet 200 mg*), σε 100-250 ml NaCl 0,9%, για μείωση της ναυτίας ή τάσης προς έμετο και για περιορισμό της γαστρικής διέγερσης.
4. Χορηγούνται αναλγητικά και σπασμολυτικά. Τοποθετούμε δηλαδή 1 amp. *Xeфо 4 mg* (ή 1 amp. *Dynastat 40 mg* ή *Viaxal 50 mg*) και 1-2 amp. *Buscopan*, εντός 100-250 ml N/S και 1 fl. 100 ml *Apotel 1 g*, ώστε να χορηγηθούν σε διάστημα 15-20 λεπτών (*στάγδην-iv*). Εναλλακτικά, 1 fl. 100 ml *Combogesic* (1 g/300 mg), παράλληλα με 1-2 amp. *Buscopan*. [Εναλλακτικά, εφόσον δεν επιτευχθεί φλεβική πρόσβαση, τότε χορηγούνται ενδομυϊκώς 1 amp. *Voltaren* μαζί με 1 amp. *Buscopan-plus* (ή *Spasmo-Apotel*), στην ίδια σύριγγα].
5. Καθιστούμε τον ασθενή, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η καταπραϊντική επενέργεια των φαρμάκων αρχίζει μετά από 15-20 λεπτά και ο πόνος θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά.
6. Επί επιμονής ή επίταξης του πόνου, μετά από την παρέλευση 30-45 λεπτών, χορηγούμε 1 amp. Πεθιδίνης* (im) ή 1 amp. Τραμαδόλης σε ορό 100 ml N/S, εντός 15-20 λεπτών ή εναλλακτικά 1 amp. Δεξτροπροποξυφαίνης (*Romidon / Zideron 75 mg*) ενδομυϊκά (im).
7. Δίνουμε διαιτητικές οδηγίες και παραπέμπουμε για U/S ήπατος/χοληφόρων/παγκρέατος.
8. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν και συνοδά συμπτώματα, όπως θετικό σημείο Murphy, υψηλός πυρετός (Θ > 38 °C) ενίοτε με ρίγος, επώδυνη χοληδόχος κύστη ή/και ίκτερος, λευκοκυττάρωση, αύξηση ηπατικών και χολοστατικών ενζύμων, υποψιαζόμαστε οξεία χολοκυστίτιδα ή οξεία χολαγγειίτιδα (**Τριάδα Charcot**: πυρετός με ρίγος, έντονο άλγος, ίκτερος ή **πεντάδα του Reynolds**: περιλαμβάνει την τριάδα Charcot, καθώς και σπητικό shock και διαταραχές του επιπέδου συνείδησης). Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούμε τα βήματα 1-4 και επιπλέον τοποθετείται ρινογαστρικός καθετήρας Levin, συστήνουμε ουδέν per os (NPO) και διακομίζουμε στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αγωγή κατ' οίκον:

1. Χορηγούμε ΜΣΑΦ, για περιορισμό του άλγους και της φλεγμονής των χοληφόρων οδών (*αφού σταθμίσουμε τα οφέλη και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο*), για 4-5 ημέρες, ήτοι:
 - tab. Voltaren 50 mg (ή Arcoxia 90 mg ή Xeφο-rapid 8 mg ή Viaxal 25 mg), 1x2.
2. Συνδυασμό σπασμολυτικού (Υοσκίνη) με αναλγητικό (Παρακεταμόλη), για 4-5 ημέρες:
 - tab. Buscopan-plus 10/500 mg (ή tab. Spasmo-Apotel 10/500 mg), 1x3.
3. Γαστροπροστασία με Ρανιτιδίνη (ή Σιμετιδίνη/Φαμοτιδίνη), ή PPIs (*Losec, Nexium*):
 - tab. Lomadryl 150 mg (ή Tagamet 200 mg ή Peptan 20 mg), 1x2, για 7-10 ημέρες.
4. Συστήνουμε βραχυχρόνια νηστεία (7-15 ημέρες), με ειδικές διατροφικές οδηγίες:

Αποφυγή των μεγάλων και λιπαρών γευμάτων. Να αποφεύγονται επίσης: τηγανητά, λιπαρά γαλακτοκομικά και παχιά τυριά, λάχανο, κρεμμύδι, αγγούρι, κρόκος αβγού, χοιρινό κρέας, παχιά αλλαντικά, λουκάνικα, ξηροί καρποί, καρύδα, σοκολάτες, καραμέλες, γλυκά με πολύ βούτυρο και αβγά, κονσέρβες σε λάδι, εντόσθια, λαδερά φαγητά, κ.λπ.

Προτιμώνται: Δημητριακά και ψωμί ολικής αλέσεως, ρύζι, άπαχα γαλακτοκομικά (*light*) και άπαχα τυριά (*ανθότυρο*), χυμοί και φρούτα, άπαχο κρέας ή ψάρι (*ψητό ή βραστό*).

5. Επί ανευρέσεως χολολίθων στο υπερηχ/φημα, επιβάλλεται η παραπομπή σε χειρουργό, με συνεννόηση και προγραμματισμό για χολοκυστεκτομή, εντός του επόμενου 3μήνου.
6. Αν ο ασθενής δεν χειρουργείται, σκεφτόμαστε τη χορήγηση UDCA (*Ursofalk*): 250 mg, 1x3 για 6-9 μήνες και επανέλεγχο των χοληφόρων με U/S σε εύλογο χρονικό διάστημα.

* Σε κολικό των χοληφόρων οδών δεν χορηγείται Μορφίνη, διότι επιτείνει τον σπασμό του σφικτήρα του Oddi, παρεμποδίζοντας κατά συνέπεια την πιθανή αποβολή του λίθου ή της λάσπης προς το 12δάκτυλο.